

れる⁵⁾。その場合はCT検査が必要となる。

一般的に特発性縦隔気腫は自然経過でも治癒する予後良好な疾患である。そのため、典型的な臨床経過（何らかの誘因がある若年者で胸痛や呼吸苦を伴う）の場合、まず胸部単純X線写真で確認し、診断がつかなければ胸部CTを施行して診断する。さらに背景疾患の有無、食道や気道系の損傷がないかを確認し治療方針を決定する。

治療と予後

特発性縦隔気腫では安静のみで自然に治癒することが多いが、外傷や医原性などの続発性縦隔気腫では原因となった基礎疾患の治療が基本となる。

縦隔構造の圧迫を伴う緊張性縦隔気腫では、胸郭運動制限に伴う拘束性障害によるチアノーゼや、肺血管の圧迫によるショック症状をきたすことがある。その

際は、経皮的縦隔切開やドレナージ術を行う必要がある。

また縦隔炎が疑われる場合は抗菌剤治療を要する。予後は死亡率が12%と不良との報告⁶⁾もあり、ドレナージ術やデブリドマン手術など侵襲的な処置を遅延なく行う必要があり、放射線科や胸部外科などと連携する必要がある。特に嘔吐に伴う特発性食道破裂（Boerhaave's syndrome）では数時間のうちに急速に状態が悪化することがあるため注意を要する。

文 献

- 1) Wintermark M, et al : Chest **120** : 543, 2001
- 2) Abolnik I, et al : Chest **100** : 93, 1991
- 3) Newcomb AE, et al : Chest **128** : 3298, 2005
- 4) Schmitt ER, et al : West J Emerg Med **12** : 526, 2011
- 5) Lemmet T, et al : Forum Infect Dis **11** : ofae225, 2024
- 6) Kaneki T, et al : Respiration **67** : 408, 2000